脳神経内科医が答える からだの不思議 #08

目がピクピクする
― 放置していいのか？

― まぶたのピクピクの正体とその見分け方 ―

医知創造ラボ　今村久司

脳神経内科専門医

こんな経験ありませんか？

「残業続きの週に、下まぶたがピクピクし始めた」

「コーヒーをたくさん飲んだ日に症状が出やすい」

「まぶたがピクピクする — 脳に異常があるのでは？」

ほぼ全員が一生に一度は経験するありふれた現象 — でも心配なケースも

眼瞼ミオキミア（Eyelid Myokymia）とは

Eyelid Myokymia（眼瞼ミオキミア）

眼輪筋の一部が自発的に不規則な電気信号を発して収縮する現象

主な引き金

- 睡眠不足 疲労
- カフェイン 過多
- ストレス 緊張
- スクリーン 疲労
- ドライアイ アルコール

下まぶた・片目のみ・細かいピクピク・引き金解消で数日以内に自然消失

メカニズム — なぜ疲れるとピクピクするのか

1

疲労・睡眠不足
カフェイン・Mg不足

▶

2

神経・筋肉の
静止電位が不安定に

▶

3

わずかな刺激で
自発放電が起きやすく
なる

▶

4

指令なしに
眼輪筋がピクッと収縮

核心メッセージ

ピクピクは「筋肉の誤作動」 — 疲労などで静止電位が不安定になっているだけ

→ 原因を取り除けば自然に落ち着く

良性と病的なピクピクの比較

項目	良性（眼瞼ミオキミア）	要注意（病的なもの）
左右	片目のみ	片目→顔半側に広がる または両目
部位	下まぶた中心 限局的	頬・口角・まぶた全体
動き方	細かくピクピク （不規則）	顔が引きつる 目がギュッと閉じる
持続時間	数秒〜数分 断続的	持続的・発作的に繰り返す
自然経過	誘因解消で 数日以内に消失	徐々に悪化 自然消失しない

放置してはいけない3つの病態

1

片側顔面痙攣 Hemifacial spasm

まぶたから始まり同側の頬・口角へ広がる。顔面神経が動脈で圧迫されることで発症。自然消失しない。

ボツリヌス毒素注射 / 微小血管減圧術

2

眼瞼痙攣 Blepharospasm

両目が意思に反して閉じてしまう。大脳基底核のジストニア。強い光・疲労・ストレスで悪化。

ボツリヌス毒素注射（第一選択）

3

マイジュ症候群 Meige syndrome

眼瞼痙攣＋口・顎・舌の不随意運動を伴う顔面ジストニア。中年以降の女性に多い。

ボツリヌス毒素注射＋薬物療法

セルフケア — 良性のピクピクへの対処法

睡眠を確保する

7〜8時間を目安に。睡眠不足は最多の引き金

Mg含む食品を意識する

ナッツ・豆腐・ほうれん草。電解質バランスを整える

カフェインを控える

コーヒー・エナジードリンクを一時的に減らす

目薬でドライアイを和らげる

人工涙液を使い、目の表面の刺激を減らす

画面から目を休める

1時間に1回、20秒以上遠くを見る（20-20-20ルール）

1〜2週間試しても改善しない場合や頬・口角への広がりがある場合は受診を

こんなときは脳神経内科へ — 受診のサイン

1. 頬や口角まで引きつりが広がる（片側顔面痙攣の可能性）
2. 両目が意思に反して閉じてしまう（眼瞼痙攣の可能性）
3. 痙攣が2週間以上続いて止まらない
4. 口・舌の不随意運動も一緒に出現している
5. 顔の麻痺（動かしにくさ）やしびれを伴う
6. 耳鳴りや難聴を伴う（顔面神経周囲の病変の可能性）

「下まぶただけ・疲れたとき限定」なら過度な心配は不要。広がる・止まらない・閉じるは要受診

「顔の動きの異常」は脳神経内科の専門領域

まぶたのピクピクに気づいたら、まず脳神経内科へ

「精神科では？」と思われがちですが、顔面の不随意運動・痙攣は脳神経内科の得意領域です。
顔面神経・大脳基底核・脳幹などの評価から、ボツリヌス治療まで一貫して対応できます。

こんな一言で受診しやすい

- 「最近まぶたがずっとピクピクしている」
- 「頬まで広がってきた気がする」
- 「目が自然に閉じてしまうことがある」

診察で行われる検査

- 問診（症状のパターン・誘因）
- 神経学的診察（顔面神経の評価）
- 必要に応じてMRI・筋電図

Take Home Message

1. 日常的な「まぶたのピクピク」の大多数は眼瞼ミオキミア
疲労・カフェイン・ストレスが引き金で自然に治る

2. 頬や口角へ広がる → 片側顔面痙攣を疑う
自然消失しないため脳神経内科へ

3. 両目が意思に反して閉じる → 眼瞼痙攣
ボツリヌス毒素注射が有効

4. 口・舌の不随意運動も伴う → マイジュ症候群
「広がる・止まらない・閉じる」が受診のサイン